

AXE 2 — MANUTENTION DU PATIENT ET POSITIONS

(Bloc 1 – Module 2 : Accompagnement du patient dans son installation et ses déplacements)

Assurer la mobilisation, l'installation et le déplacement du patient de manière :

- ❖ Sécurisée,
- ❖ Confortable,
- ❖ Adaptée à son état clinique,
- ❖ Respectueuse de son autonomie.

Toute manutention doit protéger le patient ET le professionnel.

Principes généraux de la manutention

Avant toute action, il faut toujours prendre en compte :

- Le patient (douleur, poids, autonomie, pathologie),
- L'environnement (espace, obstacles, sol),
- Le matériel disponible,
- Le nombre d'intervenants.

La manutention n'est jamais un geste isolé : c'est une décision réfléchie.

- ✓ Favoriser l'autonomie du patient
- ✓ Encourager le patient à participer selon ses capacités
- ✓ Respecter son rythme
- ✓ Valoriser les mouvements qu'il peut réaliser seul

Moins tu portes, moins tu te blesses.

Communication avant et pendant la manutention :

- ✓ Expliquer clairement la manœuvre
- ✓ Donner des consignes simples et courtes,
- ✓ Synchroniser les mouvements,
- ✓ Maintenir le contact verbal.

✗ Agir sans prévenir

☑ Agir avec le patient

I. Les positions d'attente et de transport

- ◆ Position allongée (décubitus dorsal) :
 - Patient allongé sur le dos,
 - Utilisée si l'état clinique l'impose.

- ◆ Position demi-assise :
 - Dos relevé,
 - Soulage la respiration,
 - Utilisée en cas de gêne respiratoire.

- ◆ Position jambes surélevées :
 - Favorise le retour veineux,
 - Utilisée en cas de malaise.

- ◆ Position latérale de sécurité (PLS) :
 - Patient inconscient qui respire
 - Prévention des fausses routes

La position choisie dépend de l'état du patient, pas de l'habitude.

Douleur lors des mouvements

Fatigue rapide du patient

Risque de chute

Risque de blessure du soignant

**Une bonne manutention commence toujours par une
bonne analyse.**